LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD SUBANG

PERIODE JANUARI s.d. NOVEMBER

TAHUN 2025



INSTALASI BEDAH SENTRAL
RSUD SUBANG

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah kamar operasi bisa jadi merupakan ruangan paling istimewa di rumah sakit. Pengelolaannya bisa dibilang paling khusus dibanding ruangan lain pada umumnya. Di tempat ini segala tindakan invasif bisa dilakukan terhadap tubuh manusia. Untuk menjamin tindakan operasi berjalan dengan lancar dan meminimalisir faktor-faktor pengganggu, maka perlu dilakukan pengendalian kamar operasi yang baik.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kamar operasi, kerja sama yang baik sangat diperlukan oleh para personilnya, baik dokter, perawat, anestesi maupun personil kamar operasi lainnya.

B. Tujuan Umum

Terwujudnya pengelolaan kamar operasi secara optimal sesuai dengan pedoman pelayanan instalasi bedah sentral.

C. Tujuan Khusus

Adanya laporan tahunan instalasi bedah sentral tentang:

1. Sumber daya manusia.
2. Fasilitas, bangunan, alat kesehatan
3. Standar pelayanan minimal instalasi bedah sentral
4. Kinerja produktip
5. Keselamatan pasien
6. Keselamatan kerja

BAB II
INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

A. Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Instalasi Bedah Sentral merupakan suatu kesatuan koordinasi dari beberapa unit fungsional rumah sakit pada sebuah kompleks bangunan dengan petugas terlatih dan peralatan peralatan khusus yang mempunyai sistem kerja dan sistem lingkungan tertentu guna menunjang terlaksananya proses operasi.

B. Pelayanan Bedah/Operasi

Pelayanan Yang Dilakukan Di Kamar Bedah Instalasi Bedah Sentral RSUD Subang sebagai berikut :

1. **Pelayanan Bedah Umum**
   4 Orang Dokter Spesialis Bedah Umum
2. **Pelayanan Bedah Obstetri Dan Ginekologi (Obgyn)**
   5 Orang Dokter Spesialis Obgyn
3. **Pelayanan Bedah Orthopedi**
   2 Orang Dokter Spesialis Orthopedi
4. **Pelayanan Bedah Mata**
   2 Orang Dokter Spesialis Mata
5. **Pelayanan Bedah Telinga Hidung Tenggorokan (THT)**
   1 Orang Dokter Spesialis THT
6. **Pelayanan Bedah Gigi Dan Mulut**
   1 Orang Dokter Spesialis Bedah Mulut
7. **Pelayanan Bedah Urologi**
   1 Orang Dokter Spesialis Bedah Urologi
8. **Pelayanan Bedah Paru**
   2 Orang Dokter Spesialis Paru
9. **Pelayanan Bedah Anak**
   1 Orang Dokter Spesialis Paru

C. Sifat Tindakan Operasi

1. **Operasi Elektif (Terencana)**

   Operasi Elektif adalah pembedahan terencana tanpa membahayakan nyawa pasien. Umumnya adalah pasien yang berasal dari poliklinik bedah, poliklinik kandungan, poliklinik mata, gigi dan mulut, poliklinik Telinga Hidung dan Tenggorokan, poliklinik Orthopedi, poliklinik urologi serta pasien dari unit gawat darurat maupun dari

ruangan perawatan. Penjadwalan untuk operasi dilakukan setiap hari kerja, sedangkan pelayanan operasi dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jum'at pada jam kerja.

2. Operasi CITO (Darurat)

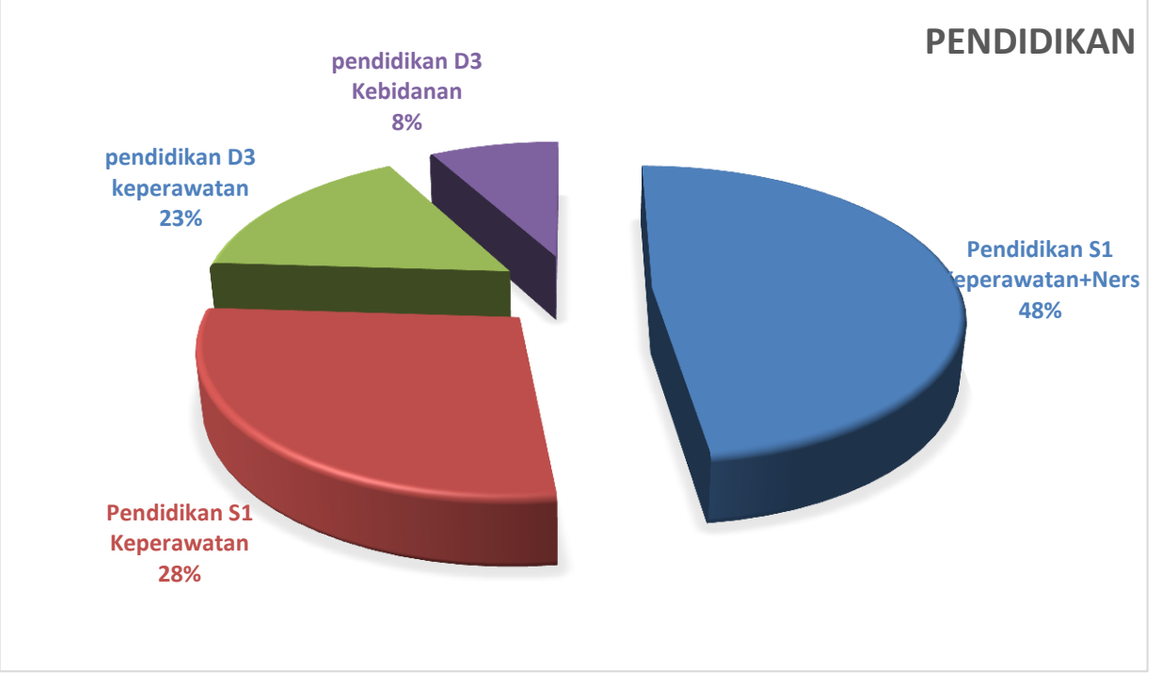
Operasi CITO adalah pembedahan yang dilakukan dalam keadaan sangat darurat dan mengancam jiwa. Tindakan operasi ini dilakukan tanpa memandang waktu, dan dikerjakan oleh tim jaga serta dokter spesialis (operator) dan dokter anestesi sesuai jenis penyakitnya.

D. Sumber Daya Dokter Spesialis

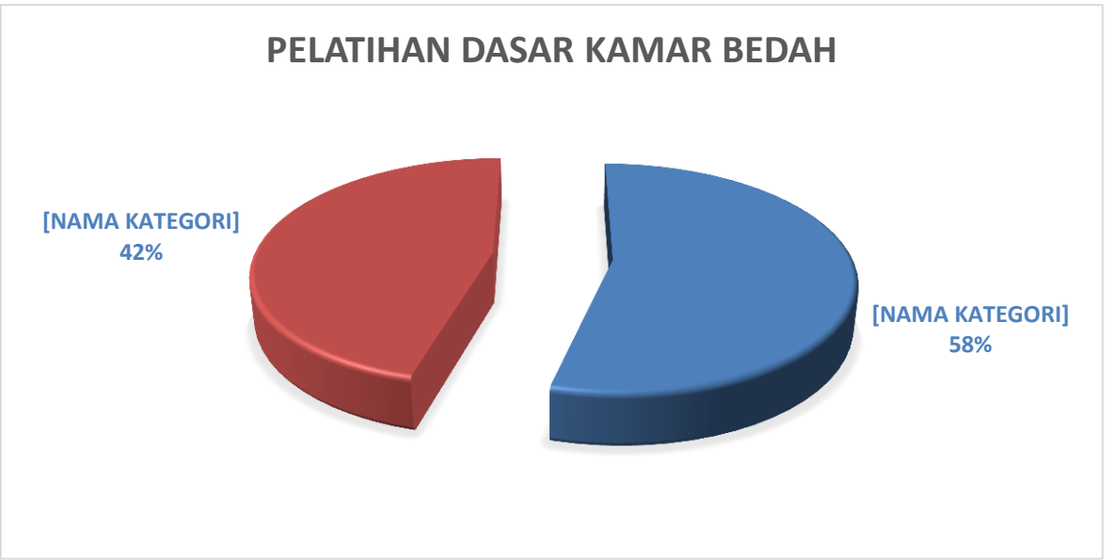
Dokter Spesialis	Nama	Jenis operasi terbanyak
Bedah Umum	1. dr. Djaja Sutisna, Sp.B. 2. dr. Ocin Sei, Sp.B 3. dr. Taufik Gumilar, Sp.B 4. dr. Fathir Yunarfan, Sp.B	Herniotomy, Appendektomi, Laparotomi, Exterpasi Dan Esksisi Tumor, Thyrodectomy, Mastectomy, Open Prostatectomy, Colostomy, Reseksi Usus, Biopsi, Dll
Bedah Orthopaedi	1. dr. Eka Mulyana, Sp.OT.(K)., FICS., M.Kes., SH., MH.Kes 2. dr.Robert Martua, Sp.OT.	Plating Pada Patah Tulang Ekstremitas, Internal Fixasi , Repair Ruptur Tendon, Remove Plate, Amputasi, Debridemen
Bedah THT-KL	dr. Prima Erlangga, Sp.THT-KL	Polip Nasal, Tonsillitis, SNNT. Biopsi Ca. Faring/Laring
Bedah Mulut	drg. Agus Sopyan, Sp.BM	Odontektomi, Labioplasty, Palatoplasty, Plating Pada Fraktur Mandibula/Maxilla, Enukleasi Kista, Reseksi Tumor Pada Mandibula/ Maxilla, Rekonstruksi Rahang Pasca Eradikasi Tumor
Bedah Obstetri Dan Ginekologi (Obgyn)	1. dr.Piliansjah Thomas, Sp.OG 2. dr. Teuku Kyan, Sp.OG 3. dr Bharata Yudha, Sp.OG 4. dr. Deni Heryanto, Sp.OG 5. dr. Rizqi Kurnia Abdullah, Sp.OG	Sectio Caesaria, Histerektomi, Tubectomy, KET, MOW,

Bedah Mata	1. dr. Elly Amalia, Sp.M 2. dr. Rama Nurrahmayana, Sp.M	FACO, ECCE, Ruptur Cornea, Pterygium, Trabectomy, Dll
Bedah Urologi	dr. Daruqutni, Sp.U	Neprolitiasis, Uretro, Vesicolitiasis, dll
Paru	1. dr. Gilang Muhammad, Sp.P 2. dr. Aprillia, Sp.P	WSD, Bronkoskopi, USG Guide Paru, dll.
Bedah Anak	Dr. Laura, Sp.BA	Herniotomy, Appendektomi, Laparotomi, Exterpasi Dan Esksisi Tumor, Thyrodectomy, Colostomy, Reseksi Usus, Biopsi, Dll

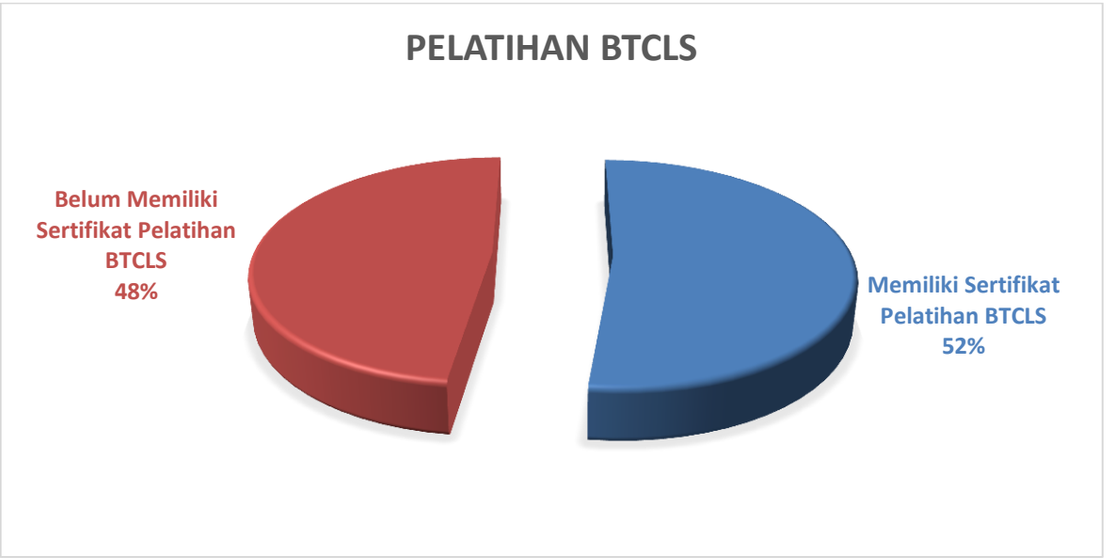
E. Sumber Daya Manusia



Analisa : Dari 25 orang tenaga keperawatan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang, 4 orang pendidikan D3 Keperawatan, 2 Orang D3 Kebidanan, 7 Orang S1 Keperawat dan, 12 Orang S1 keperawatan+Ners..



Analisa : Yang meiliki sertifikat pelatihan keperawatan dasar kamar bedah di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang ada 13 orang dan yang belum memiliki sertifikat pelatihan dasar kamar bedah ada 12 orang artinya perawat di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang belum 100% memiliki sertifikat pelatihan dasar kamar bedah.



Analisa : Yang meiliki sertifikat pelatihan BTCLS di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang ada 12 orang dan yang belum memiliki sertifikat pelatihan BTCLS ada 13 orang artinya perawat di instalasi bedah sentral RSUD Kabupaten Subang belum 100% memiliki sertifikat pelatihan BTCLS

BAB III
HASIL KEGIATAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Pola Ketenagaan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI		KEBUTUHAN	SAAT INI		TERSEDIA
		PENDIDIKAN	PELATIHAN		PENDIDIKAN	PELATIHAN	
1	Kepala Ruangan	DIII keperawatan / S1 Keperawatan	Keperawatan dasar kamar bedah		S2 Magister Manajemen Kesehatan	Keperawatan dasar Kamar bedah	
2	Ketua Tim	DIII keperawatan / S1 Keperawatan	Keperawatan dasar kamar bedah		1 orang S1 Keperawatan dan 2 orang S1 Keperawatan + Ners	3 orang sudah memiliki sertifikat keperawatan dasar kamar bedah	
3	Pelaksana	DIII keperawatan / S1 Keperawatan	Keperawatan dasar kamar bedah	12 orang belum memiliki pelatihan Keperawatan	4 orang DIII keperawatan , 7 orang S1	13 orang sudah memiliki sertifikat pelatihan	

				dasar kamar bedah	Keperawatan dan 12 orang S1 Keperawatan + Ners dan DIII Kebidanan 2 Orang	Keperawatan dasar kamar bedah	
4	Administrasi	SLTA			SLTA		
5	Cleaning Service	SLTA			SLTA		

Analisa:

Dari pola ketenagaan diatas didapat data dari 25 orang tenaga keperawatan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang , 4 Orang pendidikanya D III Keperawatan, 7 orang S 1 Keperawatan, 12 orang S 1 Keperawatan + Ners.,D III Kebidanan 2 orang Sedangkan yang memiliki sertifikat pelatihan Keperawatan dasar kamar bedah di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kelas B Kabupaten Subang ada 13 orang dan yang belum memiliki sertifikat pelatihan Keperawatan dasar kamar bedah ada 12 orang artinya perawat di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kelas B Kabupaten Subang belum 100% memiliki sertipikat pelatihan Keperawatan dasar kamar bedah.

2. Pengaturan Jaga

   Perawat yang bertugas di Intalasi Bedah sentral dalam menjalankan tugasnya selama 24 jam dibagi menjadi tiga shif, shif pagi dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, shif sore dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan shif malam dari jam 21.00 WIB sampai dengan jm 07.00 WIB. Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pada shif sore malam , maka disiapkan satu perawat umtuk oncall, dimana tugasnya untuk memenuhi tenaga pada sore malam apabila membutuhkan tenaga tambahan.

3. Penerapan Etika

   Didalam melaksanakan tugas sehari–hari perawat Instalasi Bedah Sentral diharapkan mematuhi aturan-aturan sebagai berikut ;

   a. Lakukan Tiga S (salam, senyum, sapa) kepada pasien, teman seprofesi dan profesi yang lain
   b. Melaksanakan tugas harus sesuai dengan SPO (standar prosedur operasional) yang berlaku.
   c. Melaksanakan tugas harus memperhatikan hak-hak pasien.
   d. Apabila tidak masuk kerja (ada keperluan / sakit) harus memberitahu ke ketua tim atau kepala ruangan.

4. Pengembangan Mutu

   Perawat instalasi bedah sentral pada tahun 2025 tidak ada yang mengikuti pelatihan keperawatan dasar kamar bedah. Dan perawat instalasi bedah sentral pada tahun 2022 ada yang mengikuti pelatihan BTCLS sebanyak 11 orang perawat.

JUMLAH TINDAKAN PEMBEDAHAN
INSTALASI BEDAH SENTRAL
BULAN JANUARI-NOVEMBER
2025

NO	JENIS OPERASI	KASUS	BULAN												JUMLAH KASUS
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	KECIL	BEDAH	9	-	3	3	-	5	2	5	5	13	3		
		OBGYN	-	-	-	-	4	6	4	1	27	6	46		
		THT	-	-	1	1	-	-	2	1	1	2	2		
		MATA	-	1	-	3	5	-	-	-	4	-	-		
		GIGI &MULUT	-	-	2	-	-	-	4	-	4	4	3		
		UROLOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ORTHOPEDI	-	-	-	-	-	-	3	-	-	18	-		
		BEDAH ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		PARU	-	-	-	3	6	10	10	2	3	6	13		
		JUMLAH	**9**	**1**	**6**	**10**	**15**	**21**	**25**	**9**	**44**	**49**	**67**		**256**
2	SEDANG	BEDAH	51	48	9	9	9	5	5	9	18	39	31		
		OBGYN	41	35	4	15	28	25	35	67	10	10	-		
		THT	4	3	-	1	3	-	3	-	3	-	3		
		MATA	5	4	-	-	-	-	3	2	-	-	-		
		GIGI &MULUT	4	1	4	7	3	5	5	6	4	-	3		
		UROLOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ORTHOPEDI	29	31	2	8	6	3	20	2	7	28	12		
		BEDAH ANAK	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2		

		PARU	2	10	3	-	-	-	2	-	-	-	-		
		JUMLAH	**136**	**132**	**22**	**40**	**49**	**39**	**74**	**86**	**42**	**78**	**51**		**749**
3	**BESAR**	BEDAH	28	22	47	46	40	55	76	56	84	55	55		
		OBGYN	78	71	81	95	87	87	109	71	105	90	90		
		THT	3	6	7	5	2	5	8	19	11	6	11		
		MATA	24	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		GIGI &MULUT	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-		
		UROLOGI	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-		
		ORTHOPEDI	13	9	35	43	39	68	43	72	61	45	38		
		BEDAH ANAK	-	-	-	-	1	1	7	10	17	13	6		
		PARU	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		JUMLAH	**147**	**141**	**171**	**190**	**170**	**216**	**251**	**228**	**279**	**209**	**200**		**2202**
4	**KHUSUS**	BEDAH	21	13	20	25	35	11	5	7	5	4	10		
		OBGYN	1	2	13	22	11	-	3	-	5	39	-		
		THT	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	2		
		MATA	68	72	96	98	101	121	125	116	128	127	127		
		GIGI &MULUT	-	-	-	-	2	-	-	-	-	15	-		
		UROLOGI	23	26	22	25	21	26	22	27	32	25	38		
		ORTHOPEDI	19	11	28	20	15	11	5	-	4	-	18		
		BEDAH ANAK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		PARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		JUMLAH	**133**	**124**	**179**	**191**	**186**	**171**	**162**	**150**	**174**	**210**	**195**		**1875**
JUMLAH TINDAKAN			**425**	**398**	**378**	**431**	**420**	**447**	**512**	**473**	**539**	**546**	**513**		**5082**

JUMLAH TINDAKAN OPERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG BULAN JANUARI s/d NOVEMBER 2025

1. **Jumlah Tindakan Operasi**

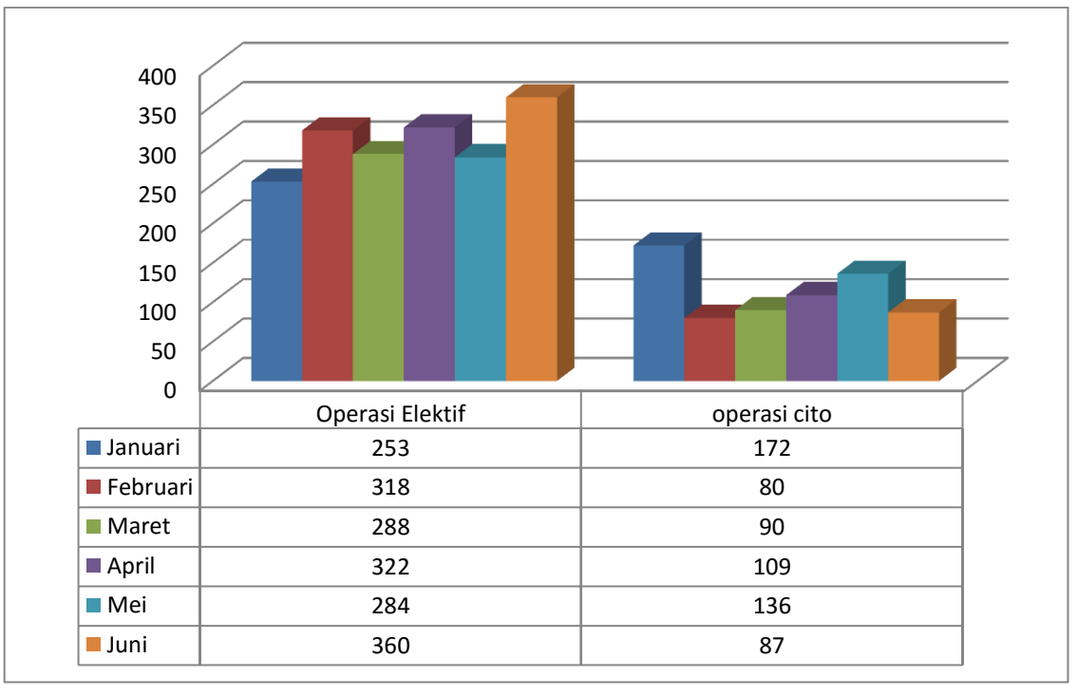
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JML
Operasi Elektif	**Jumlah**	253	318	288	322	284	360	-
	Persen	59,52%	79,90%	76,19%	74,70%	67,62%	81%	-
Operasi Cito	**Jumlah**	172	80	90	109	136	87	-
	Persen	40,48%	20,10%	23,81%	25,30%	32,38%	19%	-
Jumlah Total	**Jumlah**	425	398	378	431	420	447	-
	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

		JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
Operasi Elektif	**Jumlah**	426	395	483	454	420		**4003**
	Persen	83.21%	83.51%	89.62%	83.15 %	81.87%		**70,77%**
Operasi Cito	**Jumlah**	86	78	56	92	93		**1079**
	Persen	16.79%	16.49%	10.38%	16.85 %	18.13%		**29,23%**
Jumlah Total	**Jumlah**	512	473	539	546	513		**5082**
	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**

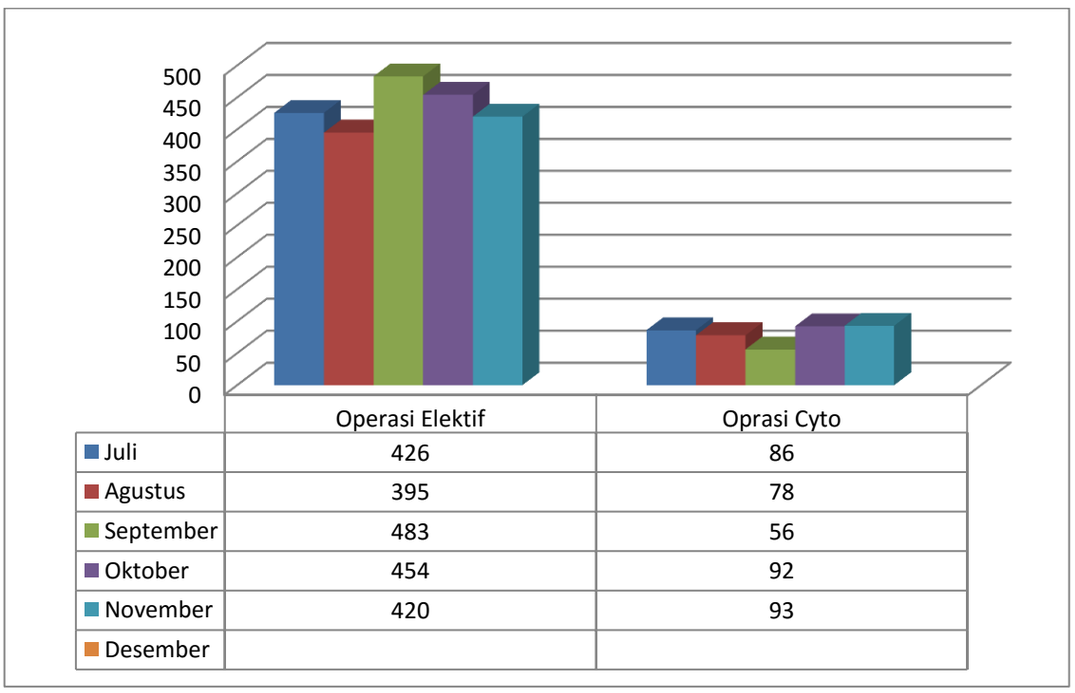
Akumulasi 11 Bulan :

Jumlah Pasien Terbanyak Di periode bulan Oktober dengan 546 Pasien Operasi dan Periode Maret Merupakan Jumlah Yang Terbawah Dengan 378 Pasien Operasi

2. Jumlah Pasien Operasi



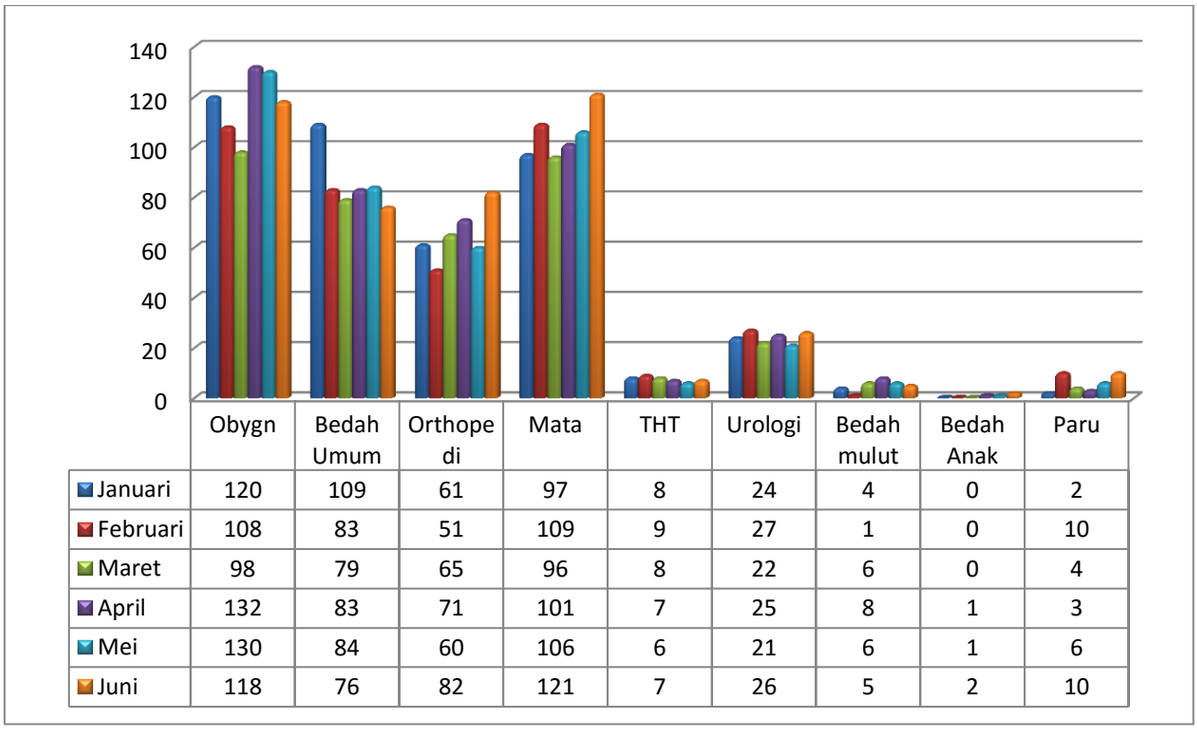
	Operasi Elektif	operasi cito
Januari	253	172
Februari	318	80
Maret	288	90
April	322	109
Mei	284	136
Juni	360	87



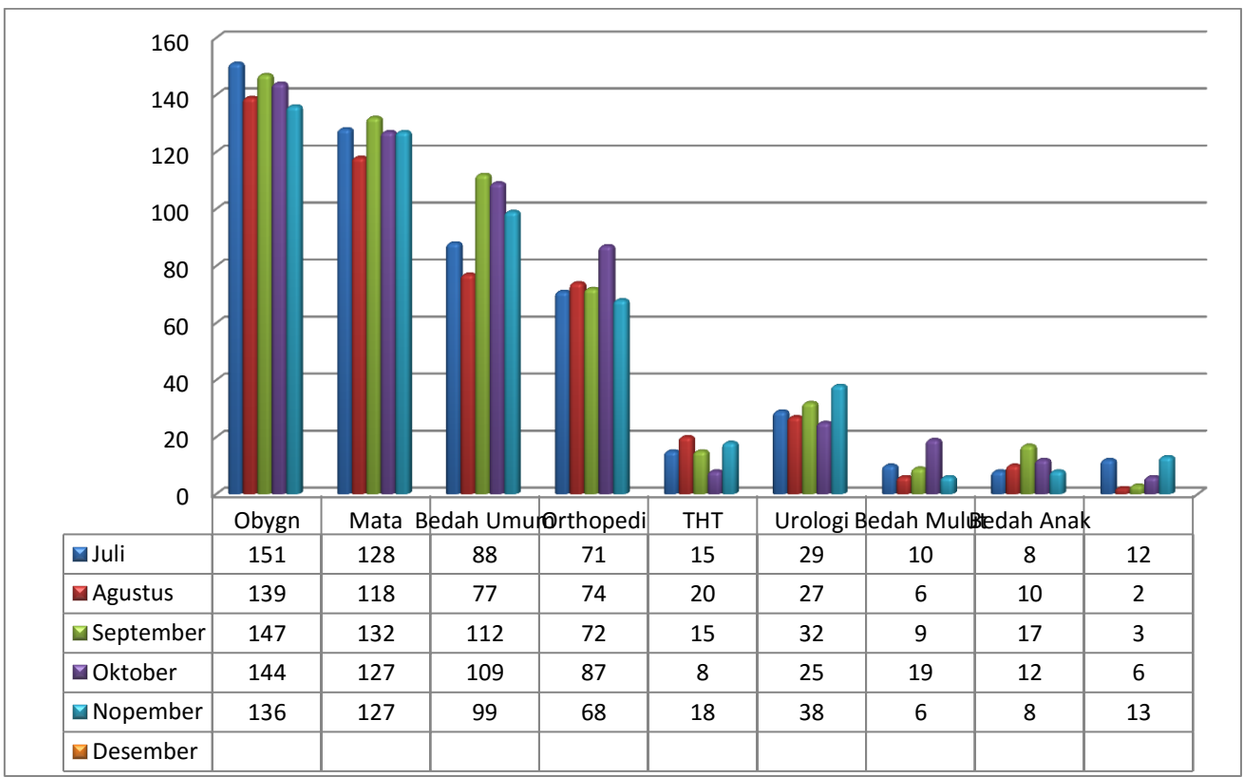
	Operasi Elektif	Oprasi Cyto
Juli	426	86
Agustus	395	78
September	483	56
Oktober	454	92
November	420	93
Desember		

Analisa : Jumlah operasi cito dan elektif diatas dalam waktu 11 Bulan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang, Elektif 4003 orang dan cyto 1079 orang.

3. Jenis Pasien Operasi



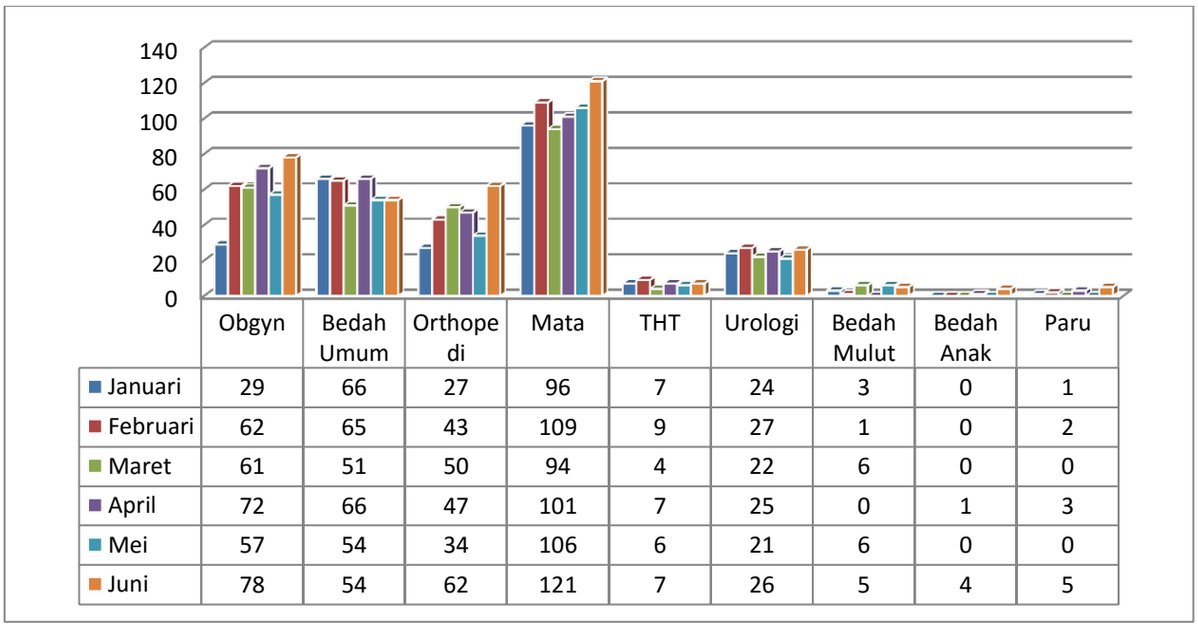
	Obygn	Bedah Umum	Orthopedi	Mata	THT	Urologi	Bedah mulut	Bedah Anak	Paru
Januari	120	109	61	97	8	24	4	0	2
Februari	108	83	51	109	9	27	1	0	10
Maret	98	79	65	96	8	22	6	0	4
April	132	83	71	101	7	25	8	1	3
Mei	130	84	60	106	6	21	6	1	6
Juni	118	76	82	121	7	26	5	2	10



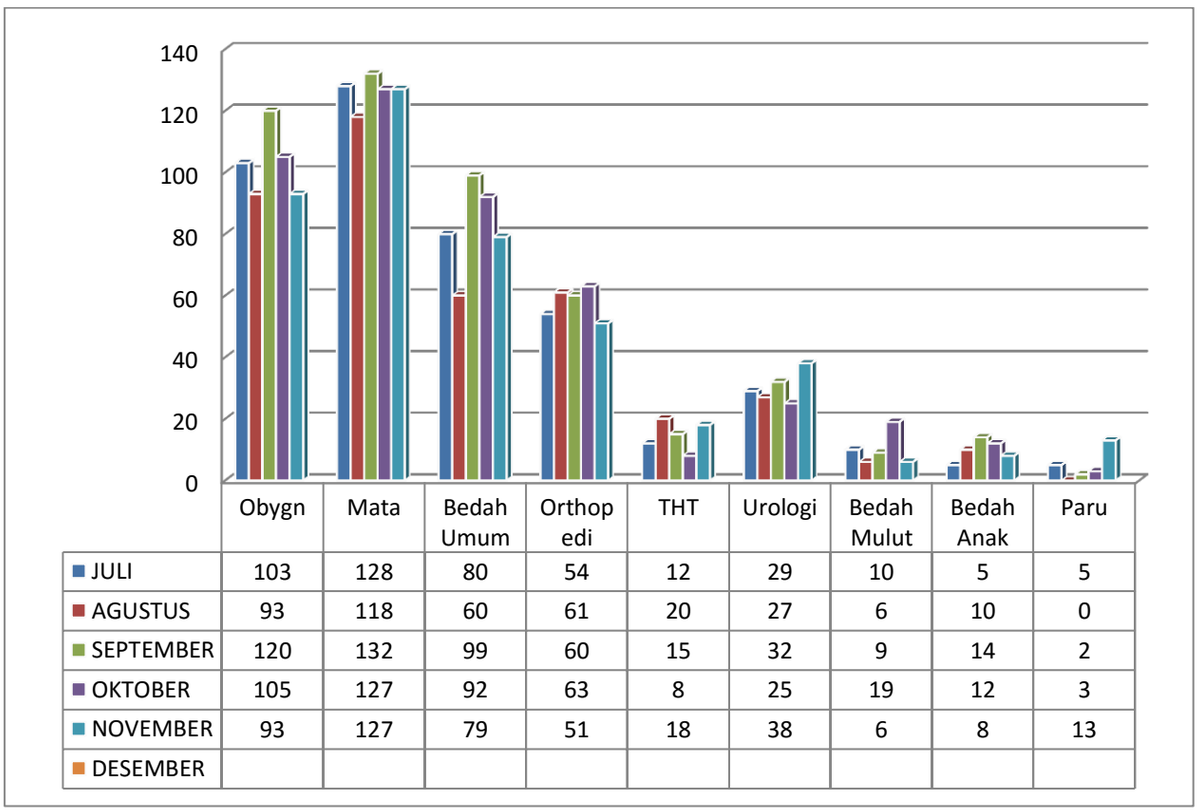
	Obygn	Mata	Bedah Umum	Orthopedi	THT	Urologi	Bedah Mulut	Bedah Anak	
Juli	151	128	88	71	15	29	10	8	12
Agustus	139	118	77	74	20	27	6	10	2
September	147	132	112	72	15	32	9	17	3
Oktober	144	127	109	87	8	25	19	12	6
Nopember	136	127	99	68	18	38	6	8	13
Desember									

Analisa :. Jumlah menurut jenis operasi terbanyak dalam waktu 11 Bulan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang jumlah pasien terbanyak Obgyn dengan 1.423 orang dan jumlah terbawah dengan Bedah Anak 59 orang.

JUMLAH OPERASI ELEKTIF ATAU TERENCANA



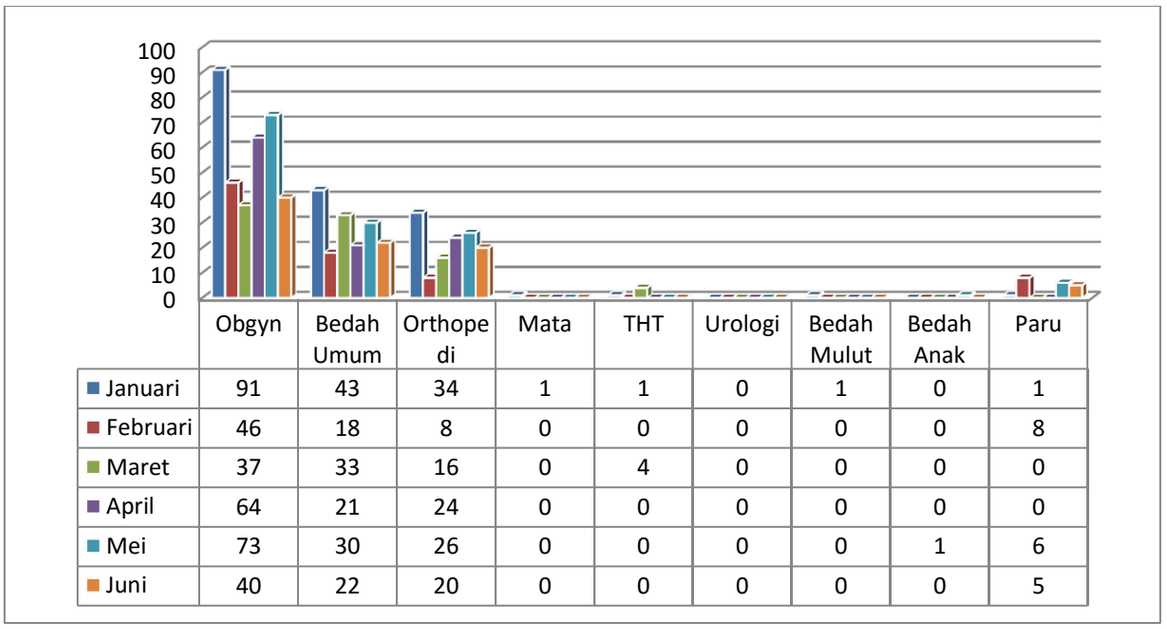
	Obgyn	Bedah Umum	Orthopedi	Mata	THT	Urologi	Bedah Mulut	Bedah Anak	Paru
Januari	29	66	27	96	7	24	3	0	1
Februari	62	65	43	109	9	27	1	0	2
Maret	61	51	50	94	4	22	6	0	0
April	72	66	47	101	7	25	0	1	3
Mei	57	54	34	106	6	21	6	0	0
Juni	78	54	62	121	7	26	5	4	5



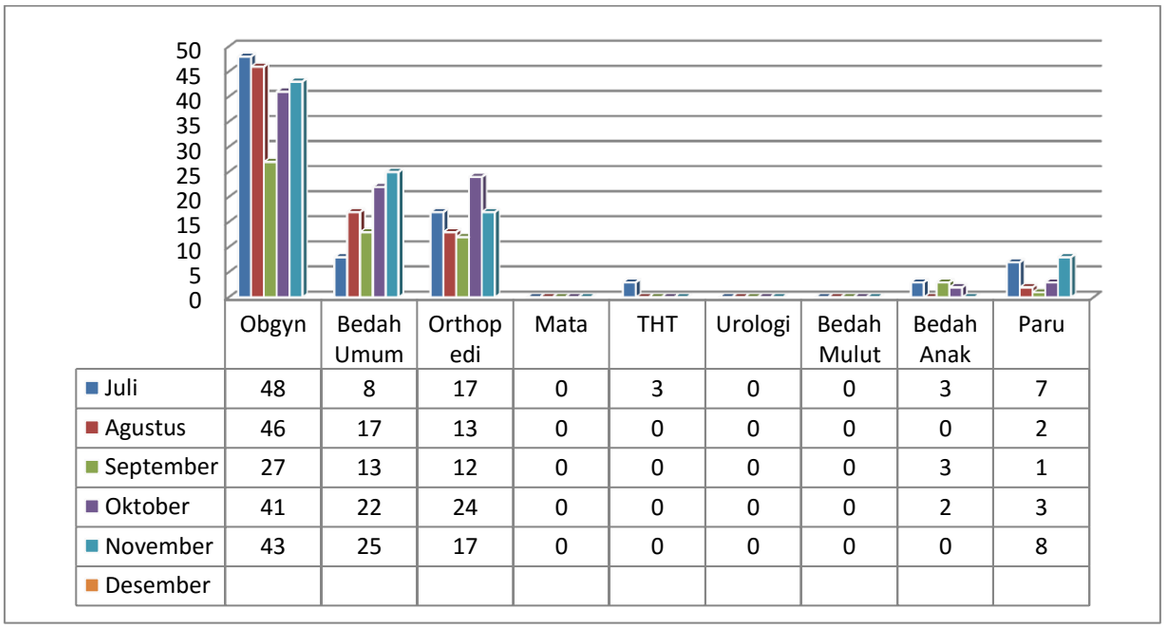
	Obygn	Mata	Bedah Umum	Orthopedi	THT	Urologi	Bedah Mulut	Bedah Anak	Paru
JULI	103	128	80	54	12	29	10	5	5
AGUSTUS	93	118	60	61	20	27	6	10	0
SEPTEMBER	120	132	99	60	15	32	9	14	2
OKTOBER	105	127	92	63	8	25	19	12	3
NOVEMBER	93	127	79	51	18	38	6	8	13
DESEMBER									

Analisa : Jumlah operasi elektif diatas dalam waktu 11 Bulan di Instalasi Bedah Sentral RSUD kabupaten Subang sebanyak 4003 orang.

JUMLAH OPERASI CITO ATAU DARURAT



	Obgyn	Bedah Umum	Orthopedi	Mata	THT	Urologi	Bedah Mulut	Bedah Anak	Paru
Januari	91	43	34	1	1	0	1	0	1
Februari	46	18	8	0	0	0	0	0	8
Maret	37	33	16	0	4	0	0	0	0
April	64	21	24	0	0	0	0	0	0
Mei	73	30	26	0	0	0	0	1	6
Juni	40	22	20	0	0	0	0	0	5



	Obgyn	Bedah Umum	Orthopedi	Mata	THT	Urologi	Bedah Mulut	Bedah Anak	Paru
Juli	48	8	17	0	3	0	0	3	7
Agustus	46	17	13	0	0	0	0	0	2
September	27	13	12	0	0	0	0	3	1
Oktober	41	22	24	0	0	0	0	2	3
November	43	25	17	0	0	0	0	0	8
Desember									

Analisa : Jumlah operasi cito diatas dalam waktu 11 Bulan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang sebanyak 1079 orang.

PERAWATAN PASCA OPERASI IBS

NO	Jenis Operasi	Ruangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jumlah
1	Bedah Umum	R.INAP	102	80	79	77	78	73	
		HCU	4	-	-	-	-	-	
		ICU	3	3	5	6	6	3	
2	Obygn	R.INAP	117	104	98	128	128	115	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	3	4	-	4	2	3	
3	Mata	R.INAP	97	109	94	101	106	121	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	-	-	-	-	-	-	
4	Orthopedi	R.INAP	61	51	65	71	60	81	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	-	-	1	-	-	1	
5	THT	R.INAP	8	9	8	7	6	7	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	-	-	-	-	-	-	
6	Urologi	R.INAP	24	27	22	25	21	26	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	-	-	-	-	-	-	
7	Bedah Mulut	R.INAP	4	1	6	8	6	5	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	-	-	-	-	-	-	
8	Bedah Anak	R.INAP	-	-	-	1	1	1	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	-	-	-	-	-	1	
9	Paru	R.INAP	1	6	-	3	6	8	
		HCU	-	-	-	-	-	-	
		ICU	1	4	-	-	-	2	

NO	Jenis Operasi	Ruangan	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Bedah Umum	R.INAP	88	72	106	109	95		959
		HCU	-	-	-	-			4
		ICU	8	5	6	5	4		54

2	Obygn	R.INAP	151	135	145	144	132		1397
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	5	4	2	2	3		32
3	Mata	R.INAP	128	118	132	127	126		1259
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	-	-	-	-	-		-
4	Orthopedi	R.INAP	71	74	72	87	67		760
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	-	-	-	-	-		2
5	THT	R.INAP	15	20	15	8	17		120
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	-	-	-	-	-		-
6	Urologi	R.INAP	29	27	32	25	37		295
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	-	-	-	-	-		-
7	Bedah Mulut	R.INAP	10	6	9	17	6		78
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	-	-	-	-	-		-
8	Bedah Anak	R.INAP	8	8	16	8	7		50
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	-	2	1	2	-		6
9	Paru	R.INAP	12	2	3	4	10		55
		HCU	-	-	-	-	-		-
		ICU	-	-	-	1	3		11
Jumlah Total									5082

REKAPITULASI PEMBATALAN OPERASI DI RUANG IBS
PERIODE JANUARI S/D NOVEMBER TAHUN 2025

NO	SUBSPESIALIS	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Bedah Umum			1										**1**
2.	Bedah Mulut								1					**1**
3.	Ortopaedi	1			2									**3**
4.	Mata	2		4	2	4	2	2	2	4	4	1		**27**
5.	Urologi													
6.	Obgyn													
7.	Bedah Anak													
8.	Paru													
9.	THT		1								1			**2**
JUMLAH														**34**

KET : JUMLAH PEMBATALAN OPERASI PERIODE JANUARI S/D NOVEMBER TAHUN 2025

SEJUMLAH : 34 PASIEN

LAPORAN PEMBATALAN OPERASI RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL

PERIODE JANUARI S/D NOVEMBER TAHUN 2025

1. JANUARI

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Tn. Somad	34Th	Haniwung	13 Jan 25	Debridement	-	Menolak Operasi	Konfirmasi dan diskusi Untuk Dilakukan Penjadawalan ulang	Dr. Eka, Sp.OT	
2	Ny. Acih	65 Th	Subang	14 Jan 25	Faco/Katarak	-	Tidak Hadir	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Elly,Sp.M	
3	Ny. Eti Damayati	64 Th	Subang	22 Jan 25	Faco/Katarak	-	Tidak Hadir	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Rama,SP.M	

2. FEBRUARI

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	An.Maritza	9.Th	Subang	10 Jan 25	Polip	-	Di Tunda (Alat ketinggalan)	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr, Prima,Sp.THT	

3. MARET

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Setianingsih	55		03-03	Katarak	Gula Darah Tinggi		Observasi dan konsultasi ke penyakit dalam, apabila Kondisi Pasien Membaik Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Rama, Sp.M	
2	Aira	1		12-03	Insisi Chalazion	Parotitis		Observasi dan konsultasi ke spesialis anak, apabila Kondisi Pasien Membaik Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Rama, Sp.M	
3	Lili	63		13-03	Katarak	Tekanan Bola Mata Tinggi		Observasi dan terapi, apabila kondisi pasien membaik dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Elly, Sp.M	
4	Tatang	57		18-03	Katarak		Keluarga ada yang meninggal	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Elly, Sp.M	
5	Caryo	65		25-03	Colelitiasis	Perbaikan K.U.		Observasi dan terapi, apabila kondisi pasien membaik dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Ocin, Sp.B	

4. APRIL

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Ny. Anah	47	Subang	04/04/2025	Close fraktur humerus	Tensi Tinggi		Observasi dan terapi, apabila kondisi pasien membaik dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Eka, Sp.OT(K)	
2	Ny. Lala Komalasari	68	Subang	11/04/2025	Ulkus Diabetikum	Perbaikan KU		Observasi dan terapi, apabila kondisi pasien membaik dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Robert, Sp.OT	

3	Ny. Iin	54	Subang	23/04/2025	Katarak	Tensi tinggi		Observasi dan terapi, apabila kondisi pasien membaik dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Elly, Sp.M	
4	Tn. Sartono	63	Subang	23/04/2025	Katarak		Tidak Datang	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Elly, Sp. M	

5. MEI

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Ny.Nursiti	69 Th	Cikadu	8 Mei 2025	Faco/Katarak	-	Tidak Datang	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr.Elly,Sp.M	
2	Ny.Karwati	67 Th	Pagaden	15 Mei 2025	Faco/Katarak	-	Tidak Datang	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr.Elly,Sp.M	
3	Tn.Saju	77 Th	Tj.Wangi	15 Mei 2025	Faco/Katarak	-	Tidak Datang	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr.Elly,Sp.M	
4	Ny.Een	57 Th	Pagaden	21 Mei 2025	Faco/Katarak	-	Tidak Datang	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr.Rama,Sp.M	

6. JUNI

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Tn.Suhandi	59 Th	Cihuni	12 juni 25	Katarak/Faco	-	BPJS Tidak Aktif	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr.Elly,Sp.M	
2	Ny.Tarminah	59 Th	Pagaden	23 Juni 25	Katarak/Faco	-	Tidak Datang	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Rama,SP.M	

7. JULI

	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Tn.Suhandi	59 Th	Cihuni	12 juni 25	Katarak/Faco	-	BPJS Tidak Aktif	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr.Elly,Sp.M	
2	Ny.Tarminah	59 Th	Pagaden	23 Juni 25	Katarak/Faco	-	Tidak Datang	Konfirmasi Untuk Dilakukan Penjadwalan Ulang	Dr. Rama,SP.M	

8. AGUSTUS

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Ny.Ela	23	Rancasari	10 Agt 2025	Abses DM pro insisi		Abses pecah	Observasi dan evaluasi	dr. Agus, Sp.BM	
2	Ny. Uar	59	Palasari	11 Agt 2025	Katarak	Tensi Tinggi		Observasi, jika keadaan stabil dilakukan penjadwalan ulang	dr. Rama, Sp.M	
3	Tn. Kaman	60	Subang	19 Agt 2025	Katarak	Tensi Tinggi		Observasi, jika keadaan stabil dilakukan penjadwalan ulang	dr. Elly, Sp.M	

9. SEPTEMBER

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Ny.RUKINAH	61	Indramayu	02 Sep 2025	Katarak		Tidak datang	Konfirmasi dan penjadwalan ulang	dr. Elly, Sp.M	

2	Ny. Oyok	72	Kp Situbiuk	11 Sep 2025	Katarak		Tidak datang	Konfirmasi dan penjadwalan ulang	dr. Elly, Sp.M	
3	Ny. Karsih	56	Purwajaya	29 Sep 2025	Katarak		Sudah operasi di RS lain	Tidak ada RTL	dr. Rama, Sp.M	
4	Tn. Sahi	54	Cibanjaran	30 Sep 2025	Katarak	Pasien dirawat		Observasi dan kolaborasi, dilakukan penjadwalan ualng	dr. Elly, Sp.M	

10. OKTOBER

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Ny. Edah	69	Cileat	06 Okt	Katarak	Kadar Gula Tinggi		Observasi dan evaluasi, jika keadaan membaik dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Rama, Sp.M	
2	Tn. Ariel	20	Otista	06 Okt	CKR + Susp fraktur VL + VE multiple		Sudah perbaikan	Observasi dan evaluasi	Dr. Prima, Sp.THTKL	
3	Tn. Tata	73	Lima ratus	15 Okt	Katarak		Sudah op di RS lain	-	Dr. Rama, Sp.M	
4	Ny. Edah	69	Cileat	27 Okt	Katarak		Tidak bisa dihubungi	Konfirmasi dan koordinasi untuk dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Rama, Sp.M	
5	Tn. Tatang	70	Bojong rongkos	29 Okt	Katarak		Tidak datang	Konfirmasi dan koordinasi untuk dilakukan penjadwalan ulang	Dr. Rama, Sp.M	

11. NOVEMBER

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TANGGAL OPERASI	JENIS OPERASI	ALASAN PENUNDAAN		RENCANA TINDAK LANJUT	OPERATOR	KET
						MEDIS	NON MEDIS			
1	Tn Solihin	58	Kp Jambelaer	04-11-2025	Katarak / Faco		Tidak Datang	Konfirmasi dan penjadwalan ulang	Dr. Elly, Sp.M	

10 BESAR OPERASI DI IBS BULAN JANUARI S/D NOVEMBER 2025

NO	DIAGNOSA	JUMLAH
1	SICS/FECO	1263
2	SC	855
3	KURETASE	475
4	DEBRIDEMENT	221
5	BPH	174
6	HERNIA	173
7	STT	52
8	WSD	41
9	REMOVAL IMPLAN	37
10	CHOLELITIASIS	33

Analisa :

Dari jumlah sepuluh besar tindakan operasi diatas dalam waktu 11 Bulan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang , urutan pertama tindakan SICS/FECO.

TABEL

JUMLAH STATUS BAYAR

INSTALASI BEDAH SENTRAL BULAN JANUARI S/D NOVEMBER 2025

STATUS BAYAR	**JML**												
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JML
UMUM	35	18	10	14	24	10	15	5	20	23	12		186
BPJS	384	367	365	413	390	422	485	443	489	504	485		4747
APBD	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12
SKTM	2	5	-	-	-	10	7	20	18	15	6		83
PG/JASA RAHARJA	-	-	3	4	6	5	5	5	12	4	10		54
JUMLAH	**425**	**398**	**378**	**431**	**420**	**447**	**512**	**473**	**539**	**546**	**513**		**5082**

Analisa : Dari jumlah status bayar diatas dalam waktu 11 Bulan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Subang, Umum 186 orang, BPJS 4747 orang, APBD 12 orang , SKTM 83 orang dan PG/Jasa Raharja 54 orang.

B. FASILITAS, BANGUNAN, ALAT KESEHATAN

1. Fasilitas

NO.	NAMA RUANGAN	STANDAR LUAS	KEBUTUHAN FASILITAS	JLH	KONDISI			KEBUTUHAN
					Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	R. Pendaftaran	3-5 m^2	Meja	1	1			1
			Kursi	3	2	1		6
			Meja Administrasi	1	1			1
			Telepon	1	1			2
			Komputer	1	1			2
			TV	1	1			1
2	R. Tunggu		Kursi tunggu pasien	6	6			3
3	Ruang Transfer (Ganti Brankar)	Sesuai keb	Brankar	1	1			1
			Jam dinding	1	1			1
4	Ruang Persiapan	Min. 9 m^2	Lemari pakaian ganti pasien	1	1			1
			Tempat Pakaian kotor pasien	1	1			1

			AC	1			1	1
5	R. Perawat	Sesuai Keb	TV	1	1			1
			Sofa	1		1		1
			AC	1	1			1
			Jam Dinding	1	1			1
6	Ruang Ganti Pakaian Perawat	Sesuai Keb	Loker	3	3			1
			Lemari Baju Bersih	1	1			1
			Tempat sampah medis	1	1			1
			Tempat baju kotor	1	1			1
7	KM/WC (petugas/Pengunjung)		Kloset	1	1			2/1
			Bak mandi	1	1			2/1
			Tempat sampah non medis	1	1			1
8	Dapur		Wastafel	1	1			1
			Lemari Pendingin	1		1		1
			Rak piring	1	1			1
			Kompor Gas	1	1			1

			Gas 12kg	1	1			1
9	Ruang Dokter	Sesuai Keb	Tempat Tidur	1	1			1
			Sofa	1	1			
			Meja	4	4			1
			Wastafel	1	1			1
			AC	2	1		1	2
			Lemari Arsip	1		1		1
			Jam Dinding	1	1			1
10	Ruang Ganti Pakaian Dokter	Sesuai Keb	Loker	2	2			1
			Tempat Sampah medis					
			Tempat baju kotor					
11	Toilet Dokter		Kloset	1	1			
			Bak mandi	1	1			
			Water Heater	1	1			
			Tempat sampah non medis	1	1			
12	Ruang Kepala Ruangan	Sesuai Keb	Meja	1	1			1

			Kursi	1	1			1
			Sofa	1	1			1
			Lemari Arsip	2	2			1
			AC	1			1	1
13	Depo Farmasi	Sesuai Keb	Lemari Obat	3	2	1		1
			Lemari Pendingin	1	1			
			Meja	1	1			1
			Kursi	1	1			2
			Komputer	1	1			1
			AC	1		1		1
14	Scrub Station	Min. 3 m^2	Wastafel dgn 2 kran	1		1		3
			Perlengkapan cuci tangan					2
			Hand scrub	Ada				
			Apron Plastik	Ada				1 per pasien
15	R. Tindakan Operasi Kamar 1		AC	2	2			1
			Jam Dinding	1	1			1

			Lemari Instrumen	2	2			1
			Tempat Sampah Medis	2	2			1
			Tempat Sampah Non Medis	1	1			1
			Tempat Linen Kotor	1	1			1
16	R. Tindakan Operasi Kamar 2		AC	2	2			1
			Jam Dinding	1	1			1
			Lemari Instrumen	2	2			1
			Tempat Sampah Medis	2	2			1
			Tempat Sampah Non Medis	1	1			1
			Tempat Linen Kotor	1	1			1
17	R. Tindakan Operasi Kamar 3		AC	2	2			1
			Jam Dinding	1	1			1
			Lemari Instrumen	1	1			1
			Tempat Sampah Medis	2	2			1
			Tempat Sampah Non Medis	1	1			1
			Tempat Linen Kotor	1	1			1

18	R. Tindakan Operasi Kamar 4		AC	1	1			1
	(K.Mata)		Jam Dinding	1	1			1
			Lemari Instrumen	1	1			1
			Meja	1	1			
			Tempat Sampah Medis	2	2			1
			Tempat Sampah Non Medis	1	1			1
			Tempat Linen Kotor	1	1			1
19	Ruang Persiapan Alat Steril		Lemari Instrumen steril	1	1			2
			Meja Alat Steril	1	1			1
20	Ruang Resusitasi Neonatus	Tgt Keb	Tempat Tidur Bayi	1	1			
			Inkubator Perawatan bayi	1	1			1
			Alat Resusitasi Bayi	1	1			1
21	Ruang Pemulihan	Min 7,2 m^2	Brankar	4	4			2
			Tiang Infus	4	4			2
			Regulator Oksigen sentral	2	2			Sentral 6 manometer
			Meja	1	1			1

			Kursi	1	1			1
			Lemari Arsip	1	1			1
			AC	1		1		1
			Tempat Sampah Medis	1	1			1
			Tempat sampah non medis	1	1			1
22	Gudang Kotor	Sesuai Keb	Container	1		1		3
23	Spoolhoek	4-6 m^2	Kloset leher angsa	1	1			1
			Keran air Bersih (sink)	1	1			1

2. Bangunan

Ruang Operasi Rumah Sakit. Suatu unit khusus di rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tindakan pembedahan secara elektif maupun akut, yang membutuhkan kondisi steril dan kondisi khusus lainnya. Ruang Operasi Rumah Sakit Subang masih menggunakan bangunan yang lama

a. Ruang Pendaftaran.

(1) Ruang ini digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi, khususnya pelayanan bedah.

(2) Ruang ini berada pada bagian depan Ruang Operasi Rumah Sakit dengan dilengkapi loket, meja kerja, lemari berkas/arsip, telepon/interkom.

(3) Pasien bedah dan Pengantar (Keluarga atau Perawat) datang ke ruang pendaftaran.

(4) Pengantar (Keluarga atau Perawat), melakukan pendaftaran di Loket pendaftaran, petugas pendaftaran Ruang Operasi Rumah Sakit melakukan pendataan pasien bedah dan penandatanganan surat pernyataan dari keluarga pasien bedah, selanjutnya pengantar menunggu di ruang tunggu.

(5) Kegiatan administrasi meliputi :

(a) Pendataan pasien bedah.

(b) Penandatanganan surat pernyataan dari keluarga pasien bedah.

(c) Rincian biaya pembedahan.

b. Ruang tunggu Pengantar.

Ruang di mana keluarga atau pengantar pasien menunggu. Di ruang ini perlu disediakan tempat duduk dengan jumlah yang sesuai aktivitas pelayanan bedah. Bila memungkinkan, sebaiknya disediakan pesawat televisi dan ruangan yang dilengkapi sistem pengkondisian udara.

c. Ruang Transfer (Transfer Room).

(1) Pasien bedah dibaringkan di *stretcher* khusus ruang operasi. Untuk pasien bedah yang datang menggunakan *stretcher* dari ruang lain, pasien tersebut dipindahkan ke *stretcher* khusus Ruang Operasi Rumah Sakit.

(2) Pasien melepaskan semua perhiasan dan diserahkan kepada keluarga pasien.

(3) Selanjutnya Pasien dibawa ke ruang persiapan (*preperation room*)

d. Ruang Tunggu Pasien (*Holding Room*).

Ruang tunggu pasien dimaksudkan untuk tempat menunggu pasien sebelum dilakukan pekerjaan persiapan (*preparation*) oleh petugas Ruang Operasi Rumah Sakit dan menunggu sebelum masuk ke kompleks ruang operasi.

Apabila luasan area Ruang Operasi Rumah Sakit tidak memungkinkan, kegiatan pada ruangan ini dapat di laksanakan di Ruang Transfer.

e. Ruang ganti pakaian (Loker).

(1) Loker atau ruang ganti pakaian, digunakan untuk Dokter dan petugas medik mengganti pakaian sebelum masuk ke lingkungan ruang operasi.

(2) Pada loker ini disediakan lemari pakaian/loker dengan kunci yang dipegang oleh masing-masing petugas dan disediakan juga lemari/tempat menyimpan pakaian ganti dokter dan perawat yang sudah disteril. Loker dipisah antara pria dan wanita. Loker juga dilengkapi dengan toilet.

f. Ruang Dokter.

Ruang Dokter terdiri dari 2 bagian :

(1) Ruang kerja.

(2) Ruang istirahat/kamar jaga.

Pada ruang kerja harus dilengkapi dengan beberapa peralatan dan furnitur. Sedangkan pada ruang istirahat diperlukan sofa. Ruang Dokter perlu dilengkapi dengan bak cuci tangan (wastafel) dan toilet.

g. Ruang Persiapan Pasien.

(1) Ruang yang digunakan untuk mempersiapkan pasien bedah sebelum memasuki ruang operasi.

(2) Di ruang persiapan, petugas Ruang Operasi Rumah Sakit membersihkan tubuh pasien bedah, dan mencukur bagian tubuh yang perlu dicukur.

(3) Petugas Ruang Operasi Rumah Sakit mengganti pakaian pasien bedah dengan pakaian khusus pasien bedah.

(4) Selanjutnya pasien bedah dibawa ke ruang induksi atau langsung ke ruang operasi.

h. Ruang Induksi.

Di ruang induksi, petugas Ruang Operasi Rumah Sakit mengukur tekanan darah pasien bedah, memasang infus, memberikan kesempatan pada pasien untuk beristirahat/ menenangkan diri, dan memberikan penjelasan pada pasien bedah mengenai tindakan yang akan dilaksanakan.

Anastesi dapat dilakukan pada ruangan ini. Apabila luasan area Ruang Operasi Rumah Sakit tidak memungkinkan, kegiatan anastesi dapat di laksanakan di kamar bedah.

i. *Scrub Station*.

(1) Scrub station atau scrub up, adalah bak cuci tangan bagi Dokter ahli bedah dan petugas medik yang akan mengikuti langsung pembedahan di dalam ruang operasi.

(2) Bagi petugas medik yang tidak terlibat tidak perlu mencuci tangannya di *scrub station.*

(3) Scrub station sebaiknya berada disamping atau di depan ruang

j. Ruang Penyiapan Peralatan/Instrumen Bedah.

Peralatan/Instrumen dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembedahan dipersiapkan pada ruang ini.

k. Kamar bedah.

(1) Kamar bedah digunakan sebagai ruang untuk melakukan tindakan operasi dan atau pembedahan. Luas ruangan harus cukup untuk memungkinkan petugas bergerak sekeliling peralatan bedah. Kamar bedah harus dirancang dengan faktor keselamatan yang tinggi.

(2) Di kamar bedah, pasien dipindahkan dari stretcher khusus Ruang Operasi ke meja operasi/bedah.

(3) Di kamar ini pasien bedah dilakukan pembiusan (anestesi).

(4) Setelah pasien bedah tidak sadar, selanjutnya proses bedah dimulai oleh Dokter Ahli Bedah dibantu petugas medik lainnya.

l. Ruang Pemulihan (*Recovery)*.

(1) Ruang pemulihan ditempatkan berdekatan dengan kamar bedah dan diawasi oleh perawat. Pasien bedah yang ditempatkan di ruang pemulihan secara terus menerus dipantau karena pasien masih dalam kondisi pembiusan normal atau ringan. Daerah ini memerlukan perawatan berkualitas tinggi yang dapat secara cepat menilai pasien tentang status : jantung, pernapasan dan physiologis, dan bila diperlukan melakukan tindakan dengan memberikan pertolongan yang tepat.

(2) Setiap tempat tidur pasien pasca bedah dilengkapi dengan minimum satu outlet Oksigen, suction, udara tekan medis, peralatan monitor dan 6 (enam) kotak kontak listrik,

(3) Kereta darurat (emergency cart) secara terpusat disediakan dan dilengkapi dengan defibrillator, saluran napas (*airway*), obat-obatan darurat, dan persediaan lainnya.

(4) Di beberapa rumah sakit, ruang pemulihan sering juga dinamakan ruang *PACU* (*Post Anaesthetic Care Unit*). Komunikasi ruang pemulihan atau ruang *PACU* langsung ke ruang dokter bedah dan perawat bedah dengan perangkat interkom. Tombol panggil darurat ditempatkan diseluruh Ruang Operasi Rumah Sakit.

3. Alat Kesehatan

NO	NAMA BARANG	JML	SATUAN	MERK/TYPE	PENERIMA		KEADAN		KEBUTUHAN
					TAHUN	ASAL	BAIK	RUSAK	
1	Bor Orthopaedi	1	Set	OSTEO POWER	2017		1		1 Set
2	Mesin Anestesi	2	Unit	CARE VISION	2017		2		
3	Monitor Scalis	1	Unit	HEYERS	2017		1		
4	Operating table	4	Unit	UZUMCU	2017		4		
5	Surgical Lamp	2	Unit	ACEM	2017		2		
6	Bed Side Monitor	3	Unit	INFINUM	2018		3		
7	Kursi Roda / Rostur	1	Unit	MAK	2018		1		2 Unit
8	mayo Table	5	Unit	UZUMCU	2018		5		
9	Mesin Urologi	1	Unit	STORS	2018		1		
10	Sectio Caesarea	1	Set	AG18-011061/MED	2018		1		
11	Suction Pump	2	Unit	UZUMCU	2018		2		
12	Tensimeter mobile	4	Unit	ERKA	2018		4		
13	Appendiktomy Set	1	Unit	Rita Leibinger	2020		1		2 Set
14	Curetage Set	1	Set	AS Medizintechnik	2020		1		1 Set
15	Haemorrhoidectomy Set	1	Set	AS Medizintechnik	2020		1		2 Set
16	Herniotomy Set	1	Unit	Rita Leibinger	2020		1		3 Set
17	Hysterektomy Set	1	Set	AS Medizintechnik	2020		1		2 Set
18	Sectio Secarian Set	1	Set	AS Medizintechnik	2020		1		2 Set
19	Tonsilectomy Set	1	Set	AS Medizintechnik	2020		1		1 Set
20	Bronco Fiber Scope	1	Set	STROZ	2021		1		
21	Endoscopy / Laparascopy	1	Unit	STROZ	2021		1		
22	Hand Pice Sytem	1	Set	SILYPS FX PHACO	2021		1		
23	Lampu (Mobaile)	1	Unit	FAMED	2021		1		
24	Lampu Mobaile	1	Unit	INSPITAL	2021		1		

25	Laparatomy Set	1	Set	RUDOLF	2021		1		
26	Meja Mayo	1	Set	UZUMCU	2021		6		5 Set
27	Meja Oprasi	3	Unit	-	2021		3		2 Unit
28	Monitor Anasthesi	1	Unit	INFINIUM	2021		1		
29	Monitor Anasthesi	1	Unit	DRAGER	2021		1		
30	Saction pamp	2	Unit	INSPITAL	2021		2		
31	Saction pamp (Mobaile)	1	Unit	INSPITAL	2021		1		
32	Saction pump	2	Unit	ONEMED	2021		2		
33	Saction pump (portable)	1	Unit	ONEMED	2021		1		
34	Sectio caesarea / Histerectomy Set	1	Set	RUDOF	2021		1		
35	Standar Infus	7	Unit	LOKAL	2021		7		
36	Tonsilectomy Set	2	Set	STROZ	2021		2		
37	Trolly Anasthesi	3	Unit	MEDINA	2021		3		
38	AC 1 PK	2	Unit	CV.NAIRA	2022		2		
39	Clip appillers patx24 oe	1	unit	PT.SOMETECH	2022		1		
40	Kursi Roda	2	Unit	WEEEL CHAIR –BKR 203	2022		2		
41	Meta clip non absortable	2	unit	PT.SOMETECH	2022		2		
42	Speciment retrival pouch	1	Unit	PT.SOMETECH	2022		1		
43	Televisi 43 inc	1	Unit	CV.TIGA PANDAWA	2022		1		
44	Troly Anasthesi	2	Unit	PT.POLARIS	2022		2		
45	Feco (mesin Mata)	1	unit	COMPACT	2023		1		
46	Lemari Kaca	2	Unit	CV. CAKRAWALA	2023				
47	Electro Cauter	1	Unit	ERBE	2024		1		
48	Lemari Kaca	1	Unit	LOKAL + TOP	2024		1		
49	Loker Baju	1	Unit	ACERO	2024		1		
50	Suction	4	Unit	OKAKU	2024		4		3 Unit
51	Colorectal Kit	1	Set	LONE STAR,MODEL3707	2025		1		
52	Endo.rectal Suction Biopsy Tools	1	Set	PT.MEDITRONIK.H.I	2025		1		

53	Instrumen Bedah Anak	1	Set	ASVIA	2025		1		
54	Instrumen Per aitem	1	Unit	ASVIA	2025		1		
56	Busi Pakai Nomer	1	Set	ASVIA	2025		1		
57	Busi Tanpa Nomer	2	Set	ASVIA	2025		2		
58	Bor Orthopedi	1	Set	AESCULAP/B.BRAUN	2025		1		
59	Lasotronic/Laser Hemorroid	1	Set	LASOTRONIC	2025		1		
60	Vena Sectio set	2	Set	PT.SUGIH INSTRUMEN	2025		2		
61	Hack Kulit	6	Set	PT.SUGIH INSTRUMEN	2025		6		

ALAT KESEHATAN

NO	NAMA BARANG	TERSEDIA		KEBUTUHAN	KETERANGAN
		JML	SATUAN		
1	Appendiktomy Set	1	Set	2 Set	
2	Endoscopy / Laparascopy set	1	Set	1 Set	
3	Haemorrhoidectomy Set	1	Set	2 Set	
4	Herniotomy Set	2	Set	3 Set	
5	Laparatomy Set	2	Set	2 Set	
6	Bor Orthopedi	1	Unit	1 Unit	
7	Orthopedic Instrument set	1	Set	1 Set	
8	Sectio Caesarea	5	Set	2 Set	
9	Curetage Set	5	Set	1 Set	
10	Hysterektomy Set	2	Set	2 Set	
11	KET Set	1	Set	2 Set	
12	Thyroiddectomy Set	1	Set	1 Set	
13	Tonsilectomy Set	3	Set	1 Set	
14	Set Urologi	1	Set	1 Set	
15	Instrumen Bedah Mulut	1	Set	1 Set	
16	Mesin Anestesi	6	Unit	2 Unit	
17	Meja Operasi	4	Unit	2 Unit	
18	Lampu Operasi Permanen	4	Unit	2 Unit	
19	Lampu Operasi Portable	3	Unit	1 Unit	
20	Mesin Elektro Cauter	4	Unit	2 Unit	
21	Suction	6	Unit	2 Unit	Persediaan 2 Unit
22	Troley Anestesi	4	Unit	2 Unit	
23	Meja Instrumen	10	Unit	5 Unit	
24	Indikator Suhu	4	Unit	4 Unit	
25	Jam Dinding	4	Unit	4 Unit	
26	Monitor Tanda Vital	6	Unit	2 Unit	
27	Jalur Oksigen sentral	5	Unit	-	
28	Lampu Baca Rontgen	3	Unit	1 Unit	
29	Lemari Instrumen	4	Unit	1 Unit	
30	Mesin Laparaskopi	2	Unit	1 unit	
31	Standar Infus	6	Buah	4 Buah	

32	Tangga Meja Pasien	2	Unit	2 Unit	
33	Tensimeter	4	Unit	4 Unit	
34	Syringe Pump	2	Unit		
35	Mesin Faco	1	Unit	1 Unit	
36	Mikroskop Mata	1	Unit	1 Unit	
37	Infus Pump	-	-	2 Unit	

D. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	URAIAN SPM	STANDAR	SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENCAPAIAN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	waktu tunggu operasi	≤ 2 hari	≤ 2 hari	Kamar operasi hanya tersedia 3 kamar	Penambahan / pembangunan gedung	≤ 2minggu		≤ 5 hari	≤ 4 hari	≤ 3 hari
2	kejadian kematian di meja operasi	≤ 1%	≤ 1%	Tidak ada kejadian meninggal d meja operasi	-	-	-	-	-	-
3	tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	-	-	-	-	-	
4	tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	Tidak ada kejadian salah Orang	-	-	-	-	-	-
5	tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	Tidak ada kejadian salah tindakan pada oprasi	-	-	-	-	-	-

6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing / alat pada tubuh pasien setelah operasi	-	-	-	-	-	-

Analisa :

Standar pelayanan minimal di Instalasi Bedah Sentral RSUD Subang, waktu tunggu operasi elektip dari mulai diputuskan untuk operasi sampai dilakukan tindakan operasi waktu tunggu masih lebih dari 2 hari, tidak ada kejadian meninggal dimeja operasi, tidak ada Kejadian operasi salah sisi, tidak ada kejadian operasi salah orang, tidak ada kejadian salah tindakan operasi, tidak ada kejadian tertinggal benda asing / alat pada tubuh pasien setelah operasi, tidak ada kejadian komplikasi anesthesia karena overdosis, reaksi anesthesia dan salah penempatan endotrakheal tube.

E. Keselamatan Pasien

Insiden Keselamatan Pasien

NO	INDIKATOR	KEJADIAN					KET
		KTD	KNC	KTC	KPC	SENTINEL	

Analisa :

Data keselamatan pasien di Instalasi Bedah Sentral RSUD Subang tahun 2025 tidak ada insiden.

F. Keselamatan Kerja

NO	INDIKATOR	KEJADIAN					KET
		KTD	KNC	KTC	KPC	SENTINEL	

Analisa : Data keselamatan kerja di Instalasi Bedah Sentral RSUD Subang Bulan januari sampai Desember tahun 2024 belum ada datanya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. SDM

Mengusulkan workshop dan pelatihan

1) Mengajukan untuk mengikuti workshop hipkabi 2 orang dibiayai oleh Rumah Sakit.
2) Mengajukan untuk mengikuti pelatihan Keperawatan dasar kamar bedah 2 orang dibiayai oleh Rumah Sakit.
3) Mengusulkan untuk mengikuti pelatihan asisten operasi katarak metode FACO 1 orang dibiayai oleh Rumah Sakit.
4) Mengusulkan untuk mengikuti pelatihan BTCLS 5 orang dibiayai oleh Rumah Sakit.

Mengusulkan penambahan tenaga perawat kamar operasi 17 orang.

Dasar perhitungan tenaga di kamar operasi

1) Jumlah dan jenis operasi
2) Jumlah kamar operasi
3) Pemakaian kamar operasi (diprediksi 6 jam per hari) pada hari kerja
4) Tugas perawat di kamar operasi; asisten operator, intrumentator, perawat sirkulasi (3 orang/tim)
5) Ketergantungan pasien :
   ► Operasi besar : 5 jam / 1 operasi
   ► Operasi sedang : 2 jam / 1 operasi
   ► Operasi kecil : 1 jam / 1 operasi [Jml. Jam perawatan / hari x Jml. Operasi] X jml pwt dlm tim Jam kerja efektif / hari
6) Di ruang penerimaan dan RR Ketergantungan pasien di ruang penerimaan : 25 menit Ketergantungan pasien di RR : 1 jam
7) Untuk perhitungan jumlah tenaga tersebut perlu ditambah (faktor koreksi) dengan : Hari libur/cuti/hari besar (loss day) Jml hari Minggu dalam 1 thn + cuti + hari besar X jml perawat tersedia Jml hari kerja efektif = 78 hari X 13 = 3,5 orang

   Tenaga kamar operasi yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam kep/hari x jumlah operasi x jumlah perawat / tim + 1}}{\text{Jam kerja efektip / hari}}$$

Rata-rata jumlah operasi perhari : 20 orang

Operasi kecil : 1 orang

Operasi sedang : 7 orang

Operasi besar+khusus : 12 orang

12 x 5 + 7 x 2 + 1 x 1 (x jumlah perawat / tim + 1

6

75 x 3 = 225 = 37,5 + 1 = 38,5 dibulatkan 38 orang

6

Ruang penerimaan

Ketergantungan pasien Ruang penerimaan : 25 menit

0,25 x 20 = 5 = 0,83 = 1 orang

6

Jumlah kebutuhan tenaga : 38 + 1 = 39 orang

Tenaga yang sudah ada 22 orang

Kekurangan tenaga 39 – 22 = 17 orang

2. FASILITAS, BANGUNAN, ALAT KESEHATAN

a. Bangunan kamar operasi sudah dicat kembali untuk mencegah terjadinya insfeksi silang .

b. Ruang pemulihan sdh dipasang gordeng dan penyekatan untuk transfer pasien

c. Perlu penambahan Alat kesehatan :

NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE	JUMLAH
1	Tray Instrumen		6 buah
2	Minor surgery set		3 set
3	Appendiktomy Set		2 set
4	Herniotomy Set		2 set
5	Neprolitotomy Set		1 set
6	Vesicolytomy Set		1 set

7	Prostatektomi set		1 set
8	Laparatomy Set		3 set
9	Sectio Caesarean Set		3 set
10	Kuretage set		2 set
11	Hysterectomy Set		2 set
12	Operating table		2 buah
13	X Ray Viewer 500 ma		4 buah
14	Operating lamp LED 160000 Lux Doble Ceilink		3 buah
15	Stretcer		3 buah
16	Kauter		4 buah
17	Suction		4 buah
18	Mayo table, hydraulic		5 buah
19	Instrument table (meja operasi)		2 buah
20	Medikal waste trolley		4 buah
21	Stool, Hydraulik (Kursi)		3 buah
22	Instrument and medicine cupboard		2 buah
23	Operating theatre cupboard		2 buah
24	Scrub Sink, Dual Controlled + brusholder(tempat cuci tangan)		2 buah
25	Ultra violet		-
26	Troli alat tenun kotor		3 buah
27	Lampu Operasi		2 Buah

3. SPM

Standar pelayanan minimal di Instalasi Bedah Sentral RSUD Subang, waktu tunggu operasi elektif dari mulai diputuskan untuk operasi sampai dilakukan tindakan operasi waktu tunggu masih lebih dari 2 hari.

4. **Kinerja Produktif**

   Jumlah tindakan jenis operasi dalam waktu 12 bulan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Subang , yang paling banyak jenis operasi elektif 3702 orang, jumlah operasi cyto 1529 orang. dan cara pembayaran sebanyak 4943 orang menggunakan BPJS.

5. **Keselamatan Pasien**

   Belum ada data

6. **Keselamatan Kerja**

   Belum ada data

B. Saran

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien yang dioperasi di instalasi bedah sentral, tidak lepas dari sarana dan prasarana yang memadai dan didukung oleh cara kerja tim yang solid

BAB V

RENCANA KERJA TAHUN 2026 RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	DANA (Rp)	WAKTU	PENANG GUNG JAWAB
1	Ketenagaan	Mengajukan pelatihan perawatan dasar kamar bedah	Perawat IBS memiliki sertipikat perawatan dasar kamar bedah	Perawat IBS	Semua perawat IBS memiliki sertipikat perawatan dasar kamar bedah	100 %		Sesuai dengan jadwal hipkabi	Diklat RSUD kabupaten Subang
		Mengajukan penambahan tenaga perawat sebanyak 1 orang sdh terpenuhi	Memenuhi standar tenaga perawat di IBS	Seksi ketenagaan dan pengembangan mutu keperawatan	Tenaga perawat di IBS terpenuhi	100 %		2026	Seksi ketenagaan dan pengembangan mutu keperawatan
2	Peralatan	• Mengajukan penambahan alat sesuai dengan kebutuhan • Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana	• Sarana dan prasarana di IBS sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat berfungsi dengan baik.	• Instrument perset • Stretcer • Semua AC yang ada di IBS	• Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana • Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana • Alat-alat dapat berfungsi dengan baik	100 %		2026	Bagian perencanaan

					• Terlaksananya perawatan ac setiap 3 bln sekali di IBS				
4	Standar Pelayanan Minimal	Mengisi asesmen peri operatip, *time out* dan (*site marking* bila diperlukan)	Tidak terjadi meninggal dimeja operasi, operasi salah sisi, operasi salah orang, salah tindakan operasi, tertinggal benda asing / alat pada tubuh pasien setelah operasi	- DPJP - Perawat IBS	Semua pasien yang dioperasi ada catatan perioperatip dan *time out* (*site marking* bila diperlukan)	100 %		2026	- DPJP - Perawat IBS
5	Produktifitas Pelayanan	Melaksanakan asisten, instrumentator dan circulating nurse pada tindakan operasi elektip dan cyto	Semua pasien yang akan dilaksanakan operasi elektip dan cyto terlayani dengan baik sesuai SPO	Pasien yang akan dioperasi	- dr tepat waktu - Pasien yang mau operasi - Perawat kamar bedah siap 24 jam - Anestesi siap 24 jam - Instrument tersedia sesuai dengan jenis pembedahan	100 %		2025	- Perawat IBS

6	Keselamatan Pasien	Mencatan setiap kejadian KTD, KNC, KTC, KPC dan sentinel	Semua kejadian keselamatan pada pasien tercatat	Semua pasie yang dioperasi	Ada catan setiap kejadian KTD, KNC, KTC, KPC dan sentinel	100 %		Setiap hari	Petugas adm IBS dan Tim PKRS
7	Pengembangan Mutu	Pertemuan sebulan sekali dengan semua petugas ibs	Menyelesaikan permasalahan yang ada di IBS	Perawat , Adm, depo dan CS IBS	• Menyelesaikan permasalahan yang ada di IBS • Terlaksana Rapat ruangan setiap bulan • Meningkatkan pelayanan	100 %		Setiap hari sabtu minggu ke 2	Kepala IBS
8	Keselamatan Kerja	Mencatan setiap kejadian KTD, KNC, KTC, KPC dan sentinel	Semua kejadian keselamatan pada pegawai IBS dicatat	Semua petugas IBS	Ada catan setiap kejadian KTD, KNC, KTC, KPC dan sentinel	100 %		Setiap hari	Petugas adm IBS dan Tim PKRS
9	Administrasi	Melaksanakan pencatatan ,pelaporan pasien yang dilakukan operasi	Semua pasien yang dilakukan tindakan operasi dikamar operasi dicatat	Pasien	• Melaksanakan pencatatan • pelaporan pasien yang dilakukan operasi • pecatatan surat masuk dan keluar	100 %		Setiap hari	Petugas adm IBS

LAPORAN HASIL KEGIATAN KEPALA RUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG
BULAN: JANUARI s.d. NOVEMBER
TAHUN 2025

RUANGAN : IBS

NO	MASALAH	PENYEBAB	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	SDM perawat kurang	Jumlah tindakan operasi tidak seimbang dengan jumlah SDM perawat yang ada	Penambahan SDM perawat	Mengajukan permohonan penambahan SDM perawat kamar bedah
2	Pengaturan jadwal pelaksanaan operasi	Jumlah kamar bedah yang tesedia kurang, disertai fisik bangunan yang mulai tidak layak	Mengatur ulang/ mengkondisikan perubahan jadwal ketika kamar operasi penuh	Mengajukan permohonan perbaikan bangunan
		Kurangnya instrumen bedah	Memenuhi jumlah set instrumen menjadi seimbang dengan jumlah kasus yang ditangani	Mengajukan permohonan penambahan instrumen bedah

3	Perawat IBS sebagian belum memiliki sertifikat pelatihan BTCLS	Masa berlaku pelatihan BTCLS habis, belum sempat mengikuti pelatihan	Mengkoordinir dan mengajukan permohonan kepada Rumah sakit untuk mengikuti pelatihan BTCLS	Mengajukan permohonan kepada bidang diklat/bidang tekait untuk pelaksanaan pelatihan BTCLS
4	Perawat IBS sebagian belum memiliki sertifikat pelatihan Bedah dasar	Belum sempat mengikuti pelatihan Bedah	Membuat nota dinas permohonan mengikuti pelatihan	Mengajukan permohonan kepada bidang diklat/bidang tekait untuk pelaksanaan pelatihan Bedah Dasar
5	Kamar operasi penuh dengan alat penunjang operasi	tidak adanya depo alat steril dan gudang mesin penunjang operasi	Disediakan ruang depo steril dan gudang alat-alat/ mesin penunjang operasi oleh rumah sakit	Mengajukan permohonan pengadaan depo alat steril dan gudang alat-alat penunjang

1. **Masalah sebagian teratasi**
   a. Instrumen bedah yang diajukan pengadaannya sebagian sudah tersedia.
   b. Sumber daya manusia ruang Instalasi Bedah Sentral terutama perawat sebagian sudah mengikuti pelatihan BTCLS dan sebagian besar lainnya akan mengikuti update BTCLS.
   c. Sumber daya manusia ruang Instalasi Bedah Sentral 60% sudah mengikuti keterampilan dasar kamar bedah.

2. **Masalah yang belum teratasi**
   a. Pengaturan jadwal pelaksanaan operasi masih ada yang terkendala terutama ketika jadwal operasi cukup banyak, ini berhubungan dengan jumlah kamar bedah yang tesedia kurang, disertai fisik bangunan yang mulai tidak layak.
   b. Fasilitas penunjang lain seperti Instalasi gas medis dan system udara dalam kamar bedah masih manual atau belum memenuhi kondisi yang stabil (masih menggunakan AC parsial).
   c. Belum tersedianya depo alat steril dan belum tersedianya ruang gudang mesin-mesin penunjang operasi sehingga barang tersebut disimpan dalam kamar operasi (penuh) .

3. **Kesimpulan**

   Selain hal-hal yang telah kami sebutkan tadi, ada simpulan lain yang terjadi tentang Instalasi Bedah Sentral, layanan tindakan operasi di IBS sekarang ini masih terbatas dengan kondisi bangunan jumlah kamar tindakan bedah hanya 3 kamar plus 1 kamar bedah mata, sedangkan jumlah jadwal harian operasi semakin banyak.

   layanan operasi serta jumlah operator bedah semakin bertambah, begitupula alat-alat penunjang canggih yang disediakan oleh managemen rumah sakit belum seluruhnya bisa dioperasikan.

   Kondisi bangunan IBS masih sama seperti tahun sebelumnya,kamarnya terlalu sedikit tidak sebanding dengan jumlah atau jadwal operasi, peristiwa berselisih dengan para operator tentang antrian jadwal operasi masih terjadi.

   Tempat tunggu keluarga pasien operasi sudah mengalami kerusakan, tampak ada bagian yang retak dan kayu renggang atau tiangnya patah sehingga berpotensi roboh dan dapat membahayakan.

   Sarana tempat istirahat dokter dan perawat berupa kursi atau sofa sudah kurang baik atau rusak sebagian serta kain gorden yang sudah rusak memerlukan pergantian.

Harapan kami : masih tidak jauh seperti sebelumnya :

1. Kami berharap diwaktu kedepan atau segera, layanan tindakan operasi dapat dilakukan di bangunan yang mempunyai ruang / kamar bedah yang lebih banyak, lebih tertata dengan tata udara dan fasilitas standar lainnya seperti yang dimiliki oleh rumah sakit lain yang sudah terakreditasi setara dengan rumah sakit diatas rumah sakit kita.

2. Kebutuhan tambahan ruangan- ruangan di IBS juga diperuntukan untuk depo distribusi, gudang penyimpanan alat-alat penunjang, alat-alat canggih, sehingga sangat penting untuk operasional serta perawatan alat-alat tersebut.
3. Jika nanti tindakan operasi dilakukan di bangunan yang berfasilitas lebih baik daripada bangunan IBS yang sekarang, masalah-masalah perselisihan antrian jadwal, kecepatan layanan, serta pengembangan keilmuan bedah dan metode layanan bedah akan dapat segera teratasi.

BAB VI
PENUTUP

Laporan hasil kerja Bulan Januari sampai November tahun 2025 di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran tindak lanjut arah kebijakan berikutnya, serta mengupayakan peningkatan pencitraan pelayanan Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Subang melalui pelayanan yang bermutu dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien sebagai dasar pelaksanaan pelayanan.

Atas perhatian dan kerjasama semua pihak saya ucapkan terima kasih.

Subang, 30 November 2025

Kepala Ruang IBS

Ade Julimar, S.Kep., Ners., M.M

NIP. 19740310200604 1 011